טיפול זוגי וקבוצת תמיכה של אמהות שורדות התעללות מינית

מרלין זסלאו

הכשרת שורדות התעללות מינית בילדות לתפקוד מוצלח דורשת לעיתים קרובות התייחסות נוספת מעבר לעיבוד הטראומה עצמה בטיפול פרטני. מאמר זה יציג גישה משולבת הכוללת טיפול זוגי וקבוצת תמיכה של אמהות שורדות גילוי עריות.

התעללות מינית בזמן הילדות, במיוחד כאשר המתעלל (או המתעללת) הוא מבוגר שזכה באמון הילד או הילדה, היא טראומה רבת השפעות על התפקוד כבוגר במערכות יחסים אינטימיות (Galinas, 1983; Weiner, 1988; Maltz, 1991). את ההחלמה משיגים בשלבים, ופעמים רבות היא כרוכה בבדיקה ארוכה של ההתעללות בעבר והשפעתה על התפקוד הנוכחי של הנפגעת. יש צורך ליישב עניינים בלתי פתורים במשפחת המוצא, ולמצוא את הדרך להתעמת עם המתעלל. נפגעת שהגיעה לידי ראייה רחבה יותר של העבר הטראומתי שלה ולרמת פתרון מסוימת, מסוגלת טוב יותר להתרכז בהתמודדות עם עתידה. היא חייבת ללמוד להתקשר שוב עם אנשים בצורה בריאה. (Herman, 1992*). יש לאפשר לשורדות, שבדרך כלל מרגישות פגומות ונושאות אות קלון, לראות את עצמן כמי שמסוגלות לתפקוד נורמלי למרות ההתעללות שסבלו. שני התחומים של תפקוד אינטימי שבהם יזדקקו כנראה לעזרה הם מיניות (Weiner, 1988; Maltz, 1991) והורות (Galinas, 1983; Cohen, 1995). הטיפול הפמיניסטי, אשר התפתח מתוך הצורך להביא להעצמה של נשים שהרגישו תכופות בלתי מועילות בחברה בעלת אוריינטציה זכרית, הוא יעיל במיוחד לטיפול בשורדות בשלב זה של ההחלמה. הרחבת הצמד הטיפולי יכולה לקדם את הטיפול. עבודה עם זוגות בטיפול בירידה בחשק המיני וגישה קבוצתית להתמודדות עם בעיות הורות הן שתי גישות שבהן השתמשתי כדי לעזור לשורדות התעללות מינית בילדותן המוקדמת לשפר את תפקודן בחיים.

כאשר נשים נמצאות בטיפול פרטני כדי לפתור סוגיות של התעללות מינית בילדותן, הן עשויות להגיע לשלב שבו רצוי לפתור בעיות בזוגיות. בנקודה זו ניתן לשלב טיפול זוגי בטיפול הפרטני. רוב שיטות הטיפול הזוגי מתאימות לטיפול בזוג הטרוסקסואלי, ובלבד שהמטפלת תהיה רגישה לסוגיות המודגשות על ידי מטפלות משפחתיות פמיניסטיות.

סוגיות אלו כוללות את השפעת הסטריאוטיפים של תפקידים מגדריים על מערכות יחסים, את המצב הבלתי נמנע של חוסר איזון בכוחות במערכות יחסים, ומעל לכל, את חובתה של המטפלת להציג הטיה לכיוון שוויון בחלוקת הכוחות במערכת היחסים. סוגיות אלה נדונו בצורה מעמיקה במקורות אחרים (Leupnitz, 1988; Walters et al., 1988), וכן במאמרים רבים שהופיעו במשך השנים בכתב העת Journal of Feminist Family Therapy. משום כך, לא אפרט כאן את השיטות שבהן אני משתמשת. במקום זאת, אתמקד בטיפול זוגי פמיניסטי בשורדות התעללות מינית כהיבט יעיל ביותר לתהליך ההעצמה שלהן. לעתים אני נפגשת עם בן הזוג או בת הזוג בשלב מוקדם של הטיפול הפרטני, עוד לפני שעלה הצורך בטיפול זוגי מקיף, ומציעה להם הסבר ראשוני על השפעות הטראומה על

נסרק עם CamScanner

התנהגות אינטימית. אני גם מכינה אותם ותומכת בהם בהתמודדות עם סערת הרגשות הצפויה להתחולל כאשר המטופלת תתמודד עם ההתעללות שחוותה בעבר. מפגשים אלה יכולים להתקיים בשלב כלשהו במהלך התהליך הטיפולי, לפי הצורך.

כאשר האשה מוכנה להתמודד עם התפקוד המיני שלה וההנאה ממין בהווה, אני מתחילה בעבודה פרטנית, ובהמשך, אם היא מעונינת בכך, אני משתפת את בן או בת הזוג. גם כאן, בנושא הטיפול המיני בנשים, ובמיוחד בנשים שעברו התעללות מינית, קיים חומר רב שנכתב ברגישות על ידי תרפיסטיות (*Barbach, 1984; Maltz, 1991). אני שבה ומדגישה כאן את העובדה שהעצמת אשה לקראת השגת סיפוק מיני חייבת להיות חלק בלתי נפרד מהטיפול בתוצאות ההתעללות המינית שעברה.

במאמר זה בחרתי להציג נקודת מבט ייחודית של תרפיה זוגית בטיפול בשורדות התעללות מינית, נקודת מבט שאינה מופיעה במקורות שאוזכרו עד כה. מספר מאפיינים משותפים לששת הזוגות המתוארים להלן גרמו לי לראות בבירור כיצד החשק המיני של נשים המחלימות מהתעללות מינית יכול להיפגע מבעיות במערכת היחסים, שלכאורה אינן קשורות למין. נוכחתי מהר לדעת שהטיפול המיני המסורתי אינו הפתרון לקשיים אלה.

בששת המקרים שאתאר כאן היתה אלי הפניה של זוגות לשם טיפול זוגי בבעיות מין במערכת היחסים, הפניה שלא נבעה מטיפול פרטני באשה. כבר בשלב המוקדם של רישום הסיפור של האשה התברר, שלכל אחת מהנשים היו חוויות מיניות בלתי נאותות. אלה כללו הטרדה מינית בילדותן, התנהגות מינית חבויה, הערות מיניות מצד בן או בת משפחה, ואונס במהלך פגישה רומנטית לפני גיל העשרה. אחת הנשים עברה בילדותה סידרה של בדיקות רפואיות פולשניות בנרתיק בנוכחות אביה, הרופא, ואחרת חייתה בתחושה מעורפלת שעברה הטרדה מינית, אולם לא היתה לה תמונה ברורה של מה שאירע. מאחר שהטיפול האחרון הסתיים באשה זו מהר ובאופן פתאומי, לא היתה הזדמנות לעבוד איתה על ההתנסות הזאת. יחד עם זאת, הורגשה השפעה מסוימת על ההיבטים המיניים של מערכת היחסים הנוכחית שלה, לאחר שתי פגישות עם בני הזוג שבהן נדונו סוגיות שליטה. לנשים האחרות ניתנה הזדמנות לעבוד באופן פרטני על סוגיות ההתעללות בנוסף לעבודה עם בני זוגן בסוגיות של מערכת היחסים ושל נושאים מיניים. אולם, מכיוון שהבנת הסוגיות הזוגיות נחשבת בעיניי לייחודית, הדגש יושם עליהן במאמר זה.

התחלתי לחשוד שכל מצב שבו האשה הרגישה נשלטת וחסרת שליטה, לא רק מצבים מיניים, יכול היה להעלות שוב תחושות מימי ההתעללות המינית בילדות, כגון הפחד הראשוני שלה וחוסר האונים, ולעורר בה כעס

בראיון הראשון של הזוגות, הן הגברים והן הנשים זיהו את הבעיה כבעיה של האשה, וציינו שהיא אינה מעונינת ביחסי מין תכופים מספיק. הם ציפו שהטיפול יופנה ישירות לסימפטום הזה, ותוצאותיו יביאו לכך שהאשה תרצה לקיים יחסי מין לעתים קרובות יותר. הנשים חשו רגשי אשמה ובושה והרגישו שמשהו בהן לקוי. כל הנשים הגיעו לטיפול עם מטען של שליטה גברית בעברן בתחומים רבים של חייהן, במיוחד בתחום המין, שנבע כנראה בחלקו מכך שהיו קורבנות בעברן, ובחלקו מעצם היותן נשים. הסטריאוטיפ של הגבר הרודף והאשה המתגוננת בהתנהגות הקשורה בחיזור קיבל ביטוי מפורש על ידי אחד הבעלים, שציין בעצב שהוא התחנך על פי העיקרון ש"אין אשה שלא נותנת, יש רק גבר שלא יודע איך לקחת". הנשים סיפרו על מקרים שבהם הסכימו ליחסי מין, אף שלא היו מעונינות בהם, ועל דרכים שבהן התאימו את עצמן לצרכיו של בן הזוג. נשים אלה התקשו להציב

נסרק עם CamScanner

גבולות ולומר "לא" גם מחוץ לזירה המינית, לבטא את קולן במערכת היחסים, ולהגיע לתחושת שליטה בתחומי חייהן הרחוקים לכאורה מסוגיות אינטימיות.

התחלתי לחשוד שכל מצב שבו האשה הרגישה נשלטת וחסרת שליטה, לא רק מצבים מיניים, יכול היה להעלות שוב תחושות מימי ההתעללות המינית בילדות, כגון הפחד הראשוני שלה וחוסר האונים, ולעורר בה כעס. האשה היתה מבולבלת בכל הקשור לזכויותיה, והרגישה שוב כקורבן חסר כוח. כתוצאה מכך היא לא הרגישה כל גירוי מיני. ייתכן שמטפלות מסורתיות בעבר היו מתייגות התנהגות זו כקרירות מינית או כהתנהגות שתלטנית מצדה – האשה שמענישה את בן זוגה בכך שהיא מונעת ממנו יחסי מין. ואולם, נשים אלה, לא במודע, שללו מין מבן זוגן, אלא הרגישו א־מיניות. נראה לי שנוצר כאן חיבור אוטומטי בין כל המצבים של דומיננטיות, לא רק מינית, לבין ההתעללות בעבר, וניתוק אוטומטי של התשוקה המינית של האשה.

הסקסולוגית הלן סינגר קפלן, שבתחילה התייחסה לחשק מיני עצור כאל קטגוריה נפרדת, העלתה את ההשערה שחשק מיני נמוך נגרם מחשיבה שלילית על מין ועל בן הזוג, דבר שגורם ל"כיבוי" אצל האדם על ידי דיכוי הגירויים המפעילים את החשק המיני האנושי (Kaplan, 1995). קפלן אינה מתייחסת לעובדה שמחשבות שליליות מתפתחות בהכרח ובאופן לגיטימי, אפילו נורמלי, כתוצאה ממצבי שליטה והתעללות בעבר ובהווה. המטפלת הפמיניסטית לינדה ויינר גורסת שמנגנוני הגנה מוקדמים של ניתוק מחשבות מיניות, רגשות מיניים ומצבים מיניים בכלל, והימנעות מהם, הם הגורמים לעכבות בתשוקה מינית (Weiner, 1988). אולם, היא אינה מתייחסת להיעדר הכוח במערכת היחסים כולה, לא רק בהיבטים המיניים, כאל דבר שיכול לעורר נתק מהתשוקה המינית. אי־הנוחות הפיזית שבה התנסו הנשים בחוויות מיניות בלתי רצויות שלא גרמו להן לעורדות, כמו גם הבושה, רגשי האשמה ורגשי הנחיתות שחשו לגבי המיניות שלהן במערכת היחסים הנוכחית, כשבני זוגן הביעו חוסר שביעות רצון מחיי המין שלהם, תרמו להתפתחות ההכרה השלילית של הנשים בכל הקשור למין. במצב כזה, ללמד אשה לחשוב חשיבה חיובית, פירושו ללמד אותה להתכחש לחוויה שעברה.

כאשר אשה מגיעה לטיפול בעקבות קשיים בתחום המיני, אני מתחילה קודם כל לבדוק את האפשרות שהיו לה חוויות מיניות שליליות בעברה. לעתים קרובות, זאת אולי המודעות הראשונה של האשה לקשר שבין ההתעללות המינית המוקדמת להתנהגות המינית המאוחרת יותר שלה. עבודה עם נשים אלה בנוכחות בן זוגן, שיוצרת זיקה בין הגורמים הללו, תורמת רבות להפחתת הסטיגמה שנושאת האשה לפיה היא היעד לטיפול מיני. בן הזוג שלה עשוי להתייחס אליה ביתר חמלה למרות הכאב והכעס שהוא חש על הדחייה המינית מצידה. כאשר אני מצביעה עליו כעל קורבן נוסף של ההתעללות המוקדמת, פעמים רבות הוא מסוגל להביע עצב בנוסף לכעס, ואולי גם לגלות נכונות רבה יותר להיות סבלני ולשתף פעולה בתהליך, הארוך לפעמים, של יצירת סביבה פנימית וחיצונית שתאפשר לאשה לשוב ולהתייחס אל מיניותה. הדבר חשוב במיוחד לזוגות שבהם שני בני הזוג ראו באשה את מטרת הטיפול, והתייחסו אליה כאל "הבעיה".

בדרך כלל ממליצים בטיפול בשורדות התעללות מינית לתת לאשה שליטה על הפעילות המינית של בני הזוג. בעבודה עם זוגות כאלה גיליתי שבנוסף לשליטה בתחום המין, חלק מהשורדות זקוקות לעבודה רבה כדי להשתחרר מהתחושה שהן נשלטות בתחומים אחרים בקשר הזוגי, לפני שהן חשות בטוחות דיין לעבוד על הסוגיות המיניות. לפעמים נראות סוגיות השליטה כה רחוקות ממין שקשה

נסרק עם CamScanner

לראות את הקשר ביניהן במבט ראשון. זוג אחד פנה לטיפול כאשר יחסי המין, שהיו מספקים עד אז, פשוט חדלו להתקיים. האשה, שהתקשתה תמיד להשפיע על החלטות, מצאה את עצמה מקריבה יותר ויותר מחייה הפרטיים והמקצועיים בהתמודדות עם עניינים משפחתיים. היא הרגישה שאיבדה שליטה ביחסים עם ילדיה, וכשאלה לא שיתפו פעולה איתה, כעסה עליהם והכתה אותם. היא חשה שבעלה זלזל בקשיים שהיו לה, וחששה להתעמת אתו בגלל תגובותיו העוקצניות והסרקסטיות בעת מריבה. היא החשיבה אותו לחכם ולמצליח ממנה, ונטתה להיכנע לטיעונים העדיפים שלו. המפגשים הפרטניים והזוגיים הביאו למערכת יחסים שוויונית יותר, והחשק המיני שלה חזר לקדמותו ללא טיפול מיני.

סוגיות של שליטה הן לעתים עדינות יותר. החיישנים של שורדות התעללות מינית בילדות ושל נשים שגדלו במשפחות בעלות תפקוד לקוי מכוונים לראות בכל מצב של שליטה סכנה מתקרבת. לא תמיד יודעות נשים אלה מדוע הן חשות בסכנה, והתפיסה של המטפלת יכולה לעזור להן להרגיש נורמליות יותר ולתת לגיטימציה לתגובותיהן. בדרך זו הן עשויות להרגיש העצמה שתאפשר להן למצוא דרכים להגיע לשליטה במצב. הצעתי לזוג צעיר מאורס לתת לאשה את השליטה ביוזמה המינית, והגבר התרעם על כך. הוא היה מאוד תלותי במערכת היחסים שלהם, והרגיש דחייה בכל פעם שרצה לבלות איתה והיא היתה עסוקה במשהו אחר. במצבים כאלה הוא נהג להסתגר, להתרחק ולהביע ספקות בעניין החתונה. היא הרגישה מאוד נשלטת, ועם זאת חשה שהבעיה המינית היתה שלה. כשדנו ביתרונות שיהיו לכך אם היא תיטול יוזמה, הוא הניע ראשו בשלילה, ואילו היא הנהנה לאות חיוב. במפגש השני הוא הביע חוסר אמון ביעילות של גישה זו. שניהם דיווחו שהיא יזמה פעילות מינית רבה יותר מאשר בעבר, והיתה מרוצה מהסידור. הם יצאו לחופשה, ולאחריה הוא התקשר להודות לי. הוא אמר שהם הבינו את הכיוון החיובי של הדברים וחשבו שהם יכולים להסתדר לבד. לא ברור לי אם מדובר בהצלחה שהושגה בשני מפגשים, או שהוא גם הצליח לשלוט בי.

כאשר מגיעה מערכת היחסים לנקודה שבה האשה מעונינת לעזור לעצמה לחוש תשוקה, אפשר להציע מגוון תרגילים ופעילויות שיעזרו לה לעורר את הרגשות המיניים במקום לדכא אותם (Maltz, 1991; Kaplan, 1995). אולם, ניסיונות לשנות עמדות מיניות ופעילות מינית בטרם זמן נידונים לכישלון. עד שתתבטל השליטה הגברית והאשה תשיג תחושה של יכולת בחייה, היא לא תשתף פעולה בעבודה על המיניות שלה. האשה עלולה לחוות התערבות בלתי הולמת בכיוון זה ככפייה, והיא עשויה לראות במטפלת עוד כוח ששולט בחייה.

כמטפלת פמיניסטית, אני מוצאת את עצמי מתמודדת בשלב זה עם דילמות שאינן מנת חלקם של סקסולוגים ושל מטפלים מסורתיים יותר. כך למשל, במקרה אחד שוחחתי עם מטופלת על מצבים שבהם העמדות ההכרתיות השליליות שלה הן אלה שאולי מנעו ממנה מלהתמקד בחשק המיני שלה. היא סיפרה על אירוע אחד: היא התפשטה ובעלה החל ללטף ולגרות אותה. אף שהרגישה התעוררות מינית, היא היתה מודעת לכך שהעמידה שלה מעייפת אותה והעדיפה לשכב במיטה. היא גם היתה מודעת לכך שבעלה מחפש גיוון ותמיד מנסה לשכנע אותה לנסות תנוחות חדשות ומקומות שונים, ולא להגביל את הפעילות המינית למיטה. היא התמקדה בהתנגדות הצפויה שלו להצעתה, ומן הסתם, רמת גירוי שלה ירדה.

מה עושים? דרך אחת היא לעזור לה לחשוב כיצד היא תוכל להמשיך ולהתמקד בגירוי מבלי לדאוג לכך שתתעייף, ומבלי לחשוש מהתגובה של בעלה, פשוט לזרום עם המצב ולהתמקד בגירוי. קפלן

נסרק עם CamScanner

ממליצה להדגיש את ההיבט החיובי ולהפנות פחות תשומת לב לשלילי. אולם, זהו בדיוק העניין: הצורך שלה שיאמין לה כשהיא אומרת שלא נוח לה, ולא ינסה להתגבר על מה שהוא רואה כהתנגדות, עלה לדיון פעמים אחדות בטיפול הזוגי. בעלה היה מודע להעדפה שלה, אבל המשיך להעמיד אותה באותו מצב.

כאשר שוחחתי איתה על כך ועודדתי אותה להעלות את הנושא בפגישה המשותפת הקרובה, בחרתי לעבוד על חיזוק תחושת היכולת שלה בתוך מערכת היחסים ביניהם, ולא לעודד אותה לוותר בנקודה זו. בעלה היה חייב להבין שגם לו יש אפשרויות בחירה, ושחלק מהבחירות יעודדו את אשתו להגיב, ובחירות אחרות ירפו את ידיה, לא בגלל שיש לה בעיה מינית. במפגש מאוחר יותר היא ביטאה את ההבנה שלה בנקודה זו. בעלה סיפר שאשתו מגלה עניין רב יותר במין, ושהמין מהנה יותר. כששאלתי אותה איך היא מרגישה ביחס להערה זו, היא הפתיעה אותי כשאמרה: "די. אני לא רוצה לשמוע שאני ילדה טובה ושמצבי משתפר. אני רוצה לדבר על הדברים שמשתנים במערכת היחסים בינינו וגורמים לי לרצות מין וליכולת שלי ליהנות ממנו יותר."

בדרך כלל, ההתנהגות המינית הגברית נחשבת לסטנדרט הקובע, ומיניות האשה נמדדת על פיו. ואולם, תזמון ותנאים שמתאימים לגבר לא בהכרח יתאימו לאשה, ואין כל סיבה שבשל כך היא תיחשב לחריגה.

קפלן טוענת שאפשר להשתמש בכל פנטזיה בארוטיקה, גם כזו שצמחה ממצבי התעללות (Kaplan, 1995). לשיטתה, יש לעודד את המטופלת להשתמש בפנטזיות אלה, ולמעשה, ניסיונות למחוק אותן אינם מומלצים ואף לא יוכתרו בהצלחה. הפנטזיה המינית של אחת הנשים היתה קשורה למצב של התעללות רפואית בילדותה, שבו הרגישה מפוחדת, נשלטת ומושפלת. אף שהפנטזיה לא היתה נעימה, היא ריגשה אותה מינית. לאחר כשהתברר לה, בעבודה על התנסויות מן העבר הקשורות לגופה, שמדובר במצב של התעללות, הפנטזיה הזו כבר לא עבדה. בעלה, שהיה שתלטן מבחינה פסיכולוגית, התעמת אתי. הוא טען שלא הייתי צריכה להתערב בפנטזיות שלה, ושכל פנטזיה היא לגיטימית. היא השיבה ששום התערבות חיצונית הפסיקה את הפנטזיה, ושהיא לא הרגישה בעמדה שיפוטית מצדי בעניין זה, ההכרה בהתעללות וההתמודדות עמה שיחררו אותה מהפנטזיה. היא היתה מרוצה, ואף העזה לחלוק על דעתו של בעלה בעניין זה. עכשיו היא מחפשת מצבים מגרים אחרים, עדינים יותר ורומנטיים יותר, שמתאימים לה יותר מאשר לבעלה, המעדיף גירוי תוקפני ומציצני. היא מצדה מתחזקת דייה כדי לומר "לא" לגירויים אלה. אם הוא רוצה שותפה מינית שתגיב לו, הוא חייב להאזין לה, לכבד את רצונותיה ולא לכפות עליה את התזמון שלו ואת הטעם המיני שלו.

יש מקרים שבהם אני חייבת לעזור לגבר לבחון מהי תרומתו להגבלת ההזדמנויות המיניות של בני הזוג. במדגם הקטן הזה, כמו גם בעבודה עם זוגות אחרים, גיליתי שחלק מהגברים היו תלותיים וילדותיים. הם היו זקוקים מאוד לאהדה ולתשומת לבה של הרעיה, אך יכלו לבקש אותן רק דרך מין. פעמים רבות, הדרישות המיניות של גברים אלה היו קיצוניות, והם נפגעו מאוד כשנדחו על ידי בת זוגם. כאשר אנו מערערים על הסטריאוטיפים החברתיים ש"יותר סקס זה יותר טוב", שמין הוא סוג האינטימיות היחיד שמספק גברים, ושמין מספק פירושו משגל, ומאפשרים לגברים לחוות קרבה בדרכים נוספות, אנו יכולים לעזור לגברים ולנשים להתקרב יותר זה לזו, וליהנות מיחסים שיש בהם סיפוק רב יותר.

נסרק עם CamScanner

תחום אחר שבו שורדות גילוי עריות חשות נחותות ובלתי יעילות הוא תחום ההורות. כדי לעזור לשורדות להתגבר על התדמית העצמית השלילית שלהן כאמהות, הקמתי קבוצת הורים המקיימת עשרים מפגשים (Galinas, 1983; Cohen, 1995). בדירוג עצמי בסולם של יעילות כהורים, שורדות גילוי עריות דרגו את עצמן במקום נמוך יותר מאשר אמהות אחרות, בכל התחומים שנמדדו (Cohen, 1995). אף שיש קבוצות הורים רגילות למכביר, הן אינן מתייחסות לצרכים המיוחדים של השורדות. למעשה, ייתכן שקבוצות אלה יגבירו את תחושת הניכור של השורדות ואף יפגעו בביטחונן העצמי וביכולתן.

בקבוצה הראשונה שלי היו שש נשים. הסיבות להשתתפות בקבוצה היו, בין השאר, הרצון להיות אמהות רגועות יותר, לא להעביר את החרדות שלהן לילדיהן, לתקשר טוב יותר, כך שיוכלו להיות זמינות ולהעניק יותר, וכן להיות יעילות יותר בהצבת גבולות ובהטלת משמעת. הן גם רצו להיות מסוגלות להתקרב יותר לילדיהן, ולהרגיש נוח יותר לגעת בהם. הן רצו לשוחח על רגשותיהן בנוגע לעצמן כאמהות, ולקבל תמיכה ועזרה בהרגעת הפחדים שלהן. חלקן רצו להרגיש חופשיות יותר, לפנק את עצמן ולהתפתח, מבלי להרגיש רגשי אשם.

תכנית עשרים המפגשים העניקה להן הזדמנויות לבדוק את ההורות שלהן על רקע ההתעללות שעברו, לברר סוגיות במשפחת המוצא שלהן, ולרכוש מיומנויות חדשות של הורות.

הסיבה להשתתפות בקבוצה היתה שאיפתן של הנשים להפוך לאמהות רגועות יותר: לא להעביר את החרדות שלהן לילדיהן. להיות מסוגלות להתקרב אליהם יותר ולהרגיש נוח יותר לגעת בהם.

לנשים אלו היו מאפיינים משותפים רבים. הן חשו שהן עלולות להזיק לילדיהן, ושהנזק שנגרם להן עלול להפוך אותן לאמהות רעות. כל אחת מהנשים תארה תחושות של חוסר ביטחון בכישוריה האימהיים, רגשי חרדה ואשם, פעמים רבות מבלי שיכלה לזהות סיבה אובייקטיבית לתחושות אלה. קושי משותף נוסף היה הקושי לגעת בילדיהן. אף אחת מהן לא הרגישה נוח לגעת באופן ספונטני בילדיה, במגע אוהב או אפילו סתמי. חלק מהן היו צריכות להכריח את עצמן להיניק את התינוקות שלהן ואפילו לגעת בהם, ואילו אחרות התקשו יותר לגעת בילדים כשגדלו. הנשים הביעו צורך לתת לילדיהן את מה שלהן עצמן לא היה, לפצות את עצמן בצורה כלשהי על ילדוּתן האבודה באמצעות ילדיהן. כמו כן היתה לכולן תחושת סכנה מוחשית שהילדים יעברו אף הם התעללות מינית. מושא הפחד יכול היה להיות האדם שהתעלל באמו של הילד, בן משפחה אחר או אדם זר. ברוב המקרים, אף שהן עצמן חשבו שאין בכך כל היגיון, הן לא יכלו לשלוט בפחד, וייחסו לו סיבות אמיתיות ודמיוניות, מבלי יכולת להבחין בין השניים. פחד נוסף היה שהן לא פיתחו תקשורת הולמת עם ילדיהן ויחסים פתוחים מספיק כדי לאפשר לילדים לומר להן אם מישהו מתעלל בהם.

נשים אלה דמו לקבוצת לביאות המגינות על ילדיהן מפני כל רע בכל מחיר. דבר זה הוביל לא פעם למחלוקות קשות עם אנשים ומוסדות שבהם היו הילדים קשורים. פעמים רבות, פעולות התערבות נמרצות אלה היו בלתי יעילות, והותירו את האמהות בתחושת תסכול וחוסר התאמה. בדרך כלל שגו אמהות אלה יותר בכיוון של הגנת יתר על הילדים וחרדת יתר לשלומם, מאשר בכיוון של אלימות. ואולם, לשלוש אמהות היתה היסטוריה של אלימות כלפי ילדיהן, בדרך כלל כלפי הילדים הבכורים, שאתם הרגישו חסרות יכולת להתמודד יותר מאשר עם ילדיהן האחרים. ילדים אלה נולדו בטרם החלו

נסרק עם CamScanner

האמהות בטיפול, לפני שהיו ערות לסיבות מאחורי הזעם ותחושת הקורבן שלהן, ולפני שלמדו להתמודד עם אלה. אף אחת מהאמהות לא התעללה בילדיה בזמן שבו החלה להשתתף בקבוצה.

כל הנשים הרגישו שהמפגשים היו להן לעזר. כולן הרגישו רגועות יותר, וייחסו זאת לתחושת השפיות והלגיטימציה שקיבלו מחברות הקבוצה. הן פיתחו הבנה גדולה יותר לקשר בין החוויות שעברו בילדות ובין דפוסי ההתנהגות שלהן עם ילדיהן. הבנה זו אפשרה להן חופש בחירה גדול יותר והזדמנות לשנות את התנהגותן. הן דיווחו שהן מתקשרות בצורה טובה יותר, נמצאות יותר בשליטה, ושהן אסרטיביות יותר. הן ראו שינוי גם בתגובה של הילדים ושל הבעל כלפיהן. הן היו מודעות לכך שרמת החרדות והפחדים בכל הקשור לילדיהן היתה גבוהה מן הראוי בעיניהן. הבנת חלק מהסיבות להתנהגותן עזרה להן להרגיע את עצמן ולנהוג בצורה הולמת יותר. המפגשים היו ערניים, נוגעים ללב, כואבים, לא פעם קשים לקבלה, אך ללא ספק היו שווים את המאמץ.

אני אסירת תודה על כך שההכשרה שלי בטיפול פמיניסטי אפשרה לי לשמוע את קולן של הנשים הללו, ולהתייחס אליהן עם כל מה שיש בהן. אני מאמינה שהכשרה זו אפשרה לי לראות את הצורך בגישה של טיפול משולב, ונתנה לי את האומץ לעשות זאת. יחד נאבקנו בתוויות סטריאוטיפיות מחלישות, וחיזקנו זו את זו במפגשים עם גברים שתלטניים וכנגד התפיסה הגברית של דומיננטיות במין. יחד הגדרנו מחדש מושגים כגון הגנת יתר ורגישות יתר באמהוּת, וראינו את העוצמה וההיגיון בתפיסה של כל אשה לגבי ילדיה. הנשים יכלו להגביר את היכולת שלהן ולפתח גאווה בעצמן כנשים, ואני יכולתי להרגיש מוכשרת יותר וגאה יותר ביכולתי כמטפלת.

מקורות

Barbach, Lonnie Garfield (1984). *For each other*. New York: Signet Books.

Cohen, Tamar (1995). Motherhood among incest survivors. *Child Abuse & Neglect*, 19, 1423-1429.

Galinas, D.J. (1983). The persistent negative effects of incest. *Psychiatry*, 46, 312-332.

Herman, Judith (1992)*. *Trauma and recovery*. New York: Basic Books.

Kaplan, Helen Singer (1991). *The sexual desire disorders*. New York: Brunner/Mazel.

Leupnitz, Deborah (1988). *The family interpreted*. New York: Basic Books.

Maltz, Wendy (1991). *The sexual healing journey: A guide for survivors for sexual abuse*. New York: HarperCollins

Walters, Marianne, Carter, Betty, Papp, Peggy, and Silverstein, Olga (1988). *The invisible web*. New York: Guilford Press.

נסרק עם CamScanner